DOR TORÁCICA NA EMERGÊNCIA: ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

Resumo da aula · Prof. Wilton F. Gomes · Medicina 8° período · 2026

FACULDADES pequenoPRÍNCIPE

1 É INFARTO? ECG EM 10 MIN + TROPONINA ULTRASSENSÍVEL 0/1 H

Supra de ST ou instabilidade pulam a estratificação. Sem supra e estável: dosar hs-cTn na chegada e em 1 h (ou 0/2 h). Cortes abaixo: **Elecsys hs-cTnT**, ng/L — cada ensaio tem os seus.

RULE-OUT	OBSERVAÇÃO	RULE-IN
0 h < 5 e dor > 3 h, ou **0 h < 12** e **Δ1h < 3** → IAM descartado; aplicar o HEART.	Nenhum dos critérios → 3ª dosagem em 3 h + ecocardiograma; reavaliar.	**0 h ≥ 52** ou **Δ1h ≥ 5** → IAMSSST: internar, estratificar, cateterismo.

2 PODE IR PARA CASA? HEART

	0	1	2
História	pouco suspeita	moderada	muito suspeita
ECG	normal	repol. inespecífica	desvio de ST
Idade	< 45	45–64	≥ 65
Risco	nenhum	1–2 fatores	≥ 3 ou DAC
Troponina	normal	1–3×	> 3×

MACE 6 semanas: **0–3: 1,7%** · 4–6: 16,6% · 7–10: 50,1%. **HEART ≤ 3 + rule-out → alta** com reavaliação ambulatorial. HEART ≥ 4 → estratificação não invasiva. Não usar se história muito suspeita, troponina em curva, ECG isquêmico ou instabilidade.

3 QUÃO GRAVE? KILLIP

I	sem congestão	6%
II	estertores em bases, B3, turgência jugular	17%
III	edema agudo de pulmão	38%
IV	choque cardiogênico	81%

Mortalidade hospitalar na série original (1967). Killip ≥ II contraindica betabloqueador agudo.

4 RISCO DE EVENTOS E DE SANGRAMENTO

TIMI (1 ponto cada): idade ≥ 65 · ≥ 3 FR · DAC conhecida · AAS 7 d · ≥ 2 anginas/24 h · ST ≥ 0,5 mm · marcador ↑. 0–2 baixo · 3–4 intermediário · ≥ 5 alto (6–7: 40,9% em 14 d).

GRACE (calculadora): ≤ 108 baixo · 109–140 intermediário · **> 140 alto**.

Sangramento: CRUSADE; ARC-HBR (≥ 75 anos, anticoagulação, DRC grave, anemia, plaquetopenia, sangramento/AVC prévio, câncer). Acesso radial.

5 CATETERISMO: QUEM E QUANDO (ESC 2023)

< 2 h
instabilidade/choque, dor refratária, arritmia grave/PCR, complicação mecânica, IC aguda, ST dinâmico recorrente

< 24 h
IAMSSST (rule-in), ST/T dinâmico, supra transitório, **GRACE > 140**

Seletiva
sem alto risco e baixa suspeita: teste não invasivo antes

A SBC 2021 ainda prevê < 72 h para risco intermediário. Quanto maior o risco, maior o benefício da invasiva (Fox 2010).

MEDIDAS INICIAIS — O QUE MUDOU

- **O_2** só se $SatO_2$ < 90%.
- **Morfina** não de rotina (atrasa P2Y12 oral). Nitrato para dor, se PAS ≥ 90 e sem IAM de VD/PDE-5.
- **AAS** ataque + manutenção · **anticoagulação** (enoxaparina ou fondaparinux).
- **P2Y12**: sem pré-tratamento rotineiro se cateterismo < 24 h.
- **Betabloqueador** oral só sem IC/Killip ≥ II, baixo débito ou BAV · **estatina** alta intensidade.

BAIXO RISCO: QUAL EXAME?

Angio-TC de coronárias: sensibilidade ~97%, ótimo VPN — exclui DAC obstrutiva. **Funcionais com imagem** (eco de estresse, cintilografia, RM de estresse): localizam e quantificam isquemia. **Ergométrico**: sens. ~58%, espec. ~62%; não interpretável com BRE, pré-excitação, marca-passo ou ST basal alterado (Knuuti 2018).

Byrne RA et al. ESC 2023 (Eur Heart J 2023;44:3720) · Rao SV et al. ACC/AHA 2025 (Circulation 2025;151:e771) · Diretriz SBC Dor Torácica 2025 (Arq Bras Cardiol 2025;122(9):e20250620) · Nicolau JC et al. SBC AI/IAMSSST 2021 · Six 2008 / Backus 2013 (HEART) · Antman 2000 (TIMI) · Granger 2003 (GRACE) · Killip 1967 · Subherwal 2009 · Urban 2019 · Fox 2010 · Knuuti 2018.

willfgo.github.io/aulas-fpp/risco-sca